

DOSIFICACIÓN DE MTX Y RESCATE CON AC. FOLÍNICO

(Basado en el Normograma de Bleyer, *Cancer Treatment Reviews*, 1977, 4; 87-101)

- Hiperhidratación iv 3 litros/m² y alcalinización con Bicarbonato 1 M 250 ml/12 desde 12 horas antes de la infusión como mínimo.
- Nunca iniciar infusión si existe aumento de creatinina sérica o una diuresis <125 ml/ m²/hora. Valorar sondaje uretral y asociar furosemida, acetazolamida o Manitol 20% si se precisa
- Mantener un pH urinario previo, durante y después de la infusión durante las primeras 24 horas >7,5
- Reconstituir el MTX (de 3 a 8 gramos/ m² según protocolo) con SF hasta un volumen de 500 ml e infundir en 4 horas
- En caso de combinarse la infusión con un bolo de Vincristina ésta debe administrarse 1 hora antes de la infusión de MTX
- Realizar niveles a las 20 h, 48 y 72 horas como mínimo. Manteniendo pauta de hiperhidratación y alcalinización hasta que los niveles sean <0,5 µM. En caso de alcanzar rango tóxico realizar niveles cada 12 horas modificando el rescate según los mismos.

DOSIS INICIAL DE LEDERFOLÍN: 35 mg/ m² a las 20 h oras del inicio de la infusión y previamente a conocer los niveles de MTX

TIEMPO TRAS INICIO INFUSION	CONCENTRACION SÉRICA DE MTX EN µM/L Y DOSIS DE LEDERFOLÍN CORRESPONDIENTES							
	0,01 – 0,1 µM	0,1 – 1 µM	1 – 5 µM	5 – 10 µM	10 – 25 µM	25 – 50 µM	50 – 75 µM	>75 µM
20 horas	10 mg/m²/6h	25 mg/m²/6h		50 mg/m²/6h	100 mg/m²/6h	200 mg/m²/6h	500 mg/m²/3h	750 mg/m²/3h
36 horas						350 mg/m²/6h	750 mg/m²/3h	1.000 mg/m²/3h
48 horas	25 mg/m²/6h	50 mg/m²/6h	100 mg/m²/6h	500 mg/m²/6h	500 mg/m²/6h	500 mg/m²/3h	1000 mg/m²/3h	
60 horas					500 mg/m²/3h	750 mg/m²/3h		
72 horas		100 mg/m²/6h	250 mg/m²/6h	1.000 mg/m²/3h				
84 horas								
96 horas			500 mg/m²/6h					

- Se suspende el Lederfolín cuando MTX < 0,01 µM
- Cuando se precisan < 25 mg/m²/6h y el paciente no vomita, puede completar rescate con Lederfolín por vía oral